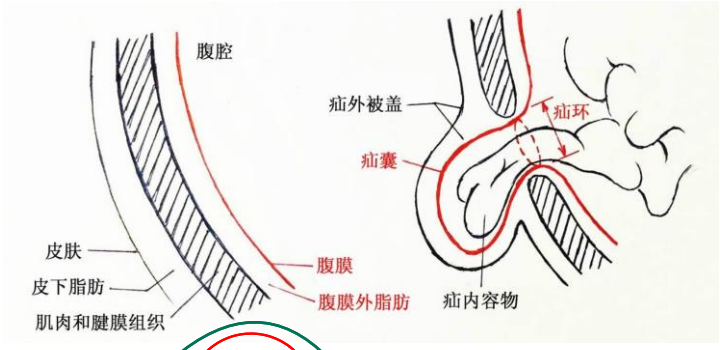
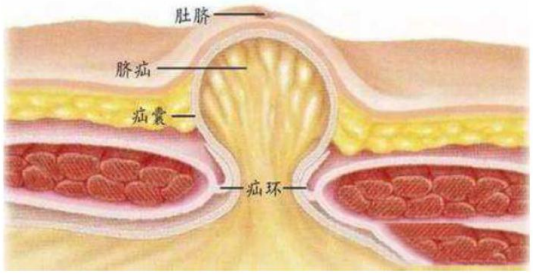
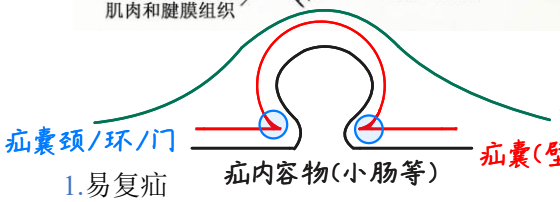
（三）疝的组成

疝内容物	如小肠、大网膜、脏层腹膜 消化道浆膜层
疝囊	壁层腹膜
疝囊颈/疝环/疝门	疝囊狭小的部分，疝命名的主要依据
疝外被盖	疝囊外的筋膜、肌肉、脂肪、皮肤等腹膜外组织





疝的外形



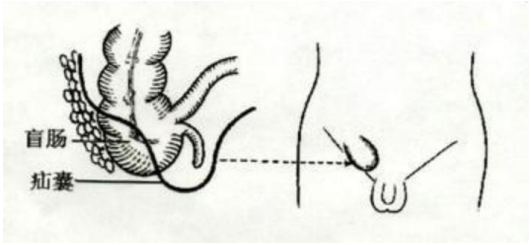
（四）疝的分类

1.易复疝

①疝内容物易回纳入腹腔（包块可消失）

②无疼痛

③最常见的疝内容物：小肠 小肠占地面积最大

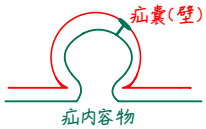


2.难复疝（粘住了） 疝内容物反复进出,与疝囊颈摩擦,会造成损伤(炎症),炎症就会有粘连

①因粘连致疝内容物不能回纳或不能完全回纳入腹腔（包块不消失）

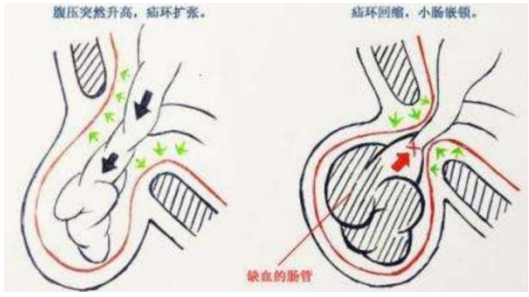
②不引起严重症状、无明显疼痛

③最常见的疝内容物：大网膜（小的难忘）



特殊的难复疝——滑动性疝（滑啊滑滑成了疝囊的一部分）

疝内容物成为疝囊的一部分→切疝囊时避免误伤疝内容物
疝内容物以盲肠(右)、阑尾、乙状结肠(左)、膀胱(中间)多见，多见于右侧
常有消化不良、便秘 活动度大



3.嵌顿疝（卡住了）→静脉回流障碍→淤血水肿→包块逐渐增大

①疝内容物被卡住而不能回纳入腹腔（包块不消失、且逐渐增大）

②疼痛明显，可伴机械性肠梗阻（肠鸣音亢进）

③包括：alarm

Richter/肠管壁疝（人民币）	嵌顿内容物仅为部分肠管壁，局部肿块不明显、多无肠梗阻、易误诊
Littre 疝 little-小	嵌顿内容物为小肠憩室如 Meckel 憩室 没扣-小气
Maydl/逆行性嵌顿疝	嵌顿肠管包括几个肠袢、呈 W 形。即使疝囊肠管存活也必须将腹腔内相关肠袢牵出检查以防隐匿在腹腔内的坏死肠袢被遗漏
Amyand 疝	嵌顿内容物为阑尾、常感染化脓（appendix）